

Genetik

White Truffle x Northern Lights



Geruch

cremig, schokoladig, würzig



Geschmack

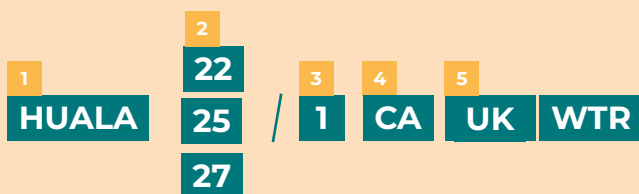
cremig, schokoladig, würzig



Wirkung

analgetisch^{1,2,3}, antiinflammatorisch^{4,5}, anxiolytisch⁶, antidepressiv⁶

Produktname



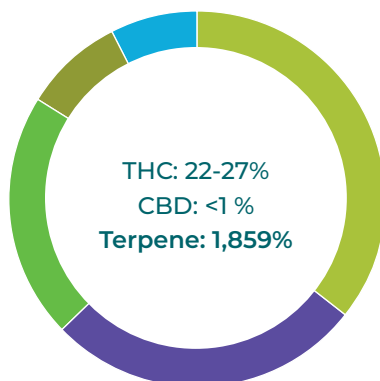
- | | | |
|--------------|------------|------------|
| 1 Eigenmarke | 2 THC SOLL | 3 CBD SOLL |
| 4 Herkunft | 5 Kultivar | |

Details zu Waffle Truffle

Waffle Truffle ist ein Indica-dominanter Hybridkultivar, der durch seine stabile Wirkung und sein vielschichtiges Aromaprofil überzeugt. Die genetische Basis setzt sich aus v Truffle Oreoz sowie einer Kreuzung aus White Truffle x Northern Lights zusammen.

Die Wirkung wird als inspirierend beschrieben, was Waffle Truffle besonders für Tageszeiten mit Bedarf an mentaler Stabilität und Energieausgleich prädestiniert. Patientinnen und Patienten berichten von Stressreduktion, Linderung von Angstzuständen sowie einer Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens.

- 29 % Beta-Caryophyllen
- 22 % Myrcen
- 17 % Limonen
- 7 % Alpha-Humulen
- 6 % Linalool
- 17 % Sonstige



Terpene

Die dominantesten Terpene der Sorte - teilweise ausschlaggebend für den Geschmack, die Wirkung & den Geruch. Mehr Infos zu Terpenen finden Sie auf dem Datenblatt über Terpene und ihre Wirkung.

Prozentualer Anteil am Gesamtterpengehalt.
Prozentangaben sind Mittelwerte über mehrere Chargen.

Dosierungsbeispiel

Beginn mit einer niedrigen Dosis und langsamen Steigerungen, bis die gewünschte Wirkung erreicht ist.

Standard-Anfangsdosis: 25-50 mg Cannabisblüte pro Tag (ca. 6,25–12,5 mg THC bei 25 % THC)^A

Unerfahrene Patienten: 10 mg Cannabisblüte pro Tag (ca. 2,5 mg THC bei 25 % THC)^B

Produktvariationen

Produktname	PZN 5g	PZN 15g	PZN 100g
420 HUALA 22/1 UK WTR	-	-	20002952
420 HUALA 25/1 UK WTR	-	-	20003093
420 HUALA 27/1 UK WTR	-	v	20003006

Rezeptanforderungen

- Bei Cannabis muss die **exakte** Produktbezeichnung analog der Herstellervorgabe auf dem Rezept angegeben werden.
- Weiterhin muss die **exakte** patientenindividuelle Zubereitung und Dosierung mit aufgenommen werden.

Quellennachweise

¹Klaue AL, Racz I, Pradier B, Markert A, Zimmer AM, Gertsch J, Zimmer A. The cannabinoid CB₂ receptor-selective phytocannabinoid beta-caryophyllene exerts analgesic effects in mouse models of inflammatory and neuropathic pain. Eur Neuropsychopharmacol. 2014 Apr;24(4):608-20. doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.10.008. Epub 2013 Oct 22. PMID: 24210682.

²Katsuyama S, Mizoguchi H, Kuwahata H, Komatsu T, Nagaoka K, Nakamura H, Bagetta G, Sakurada T, Sakurada S. Involvement of peripheral cannabinoid and opioid receptors in beta-caryophyllene-induced antinociception. Eur J Pain. 2013 May;17(5):664-75. doi: 10.1002/j.1532-2149.2012.00242.x. Epub 2012 Nov 9. PMID: 23138934.

³Fidyt K, Fiedorowicz A, Strzadala L, Szumny A. beta-caryophyllene and beta-caryophyllene oxide-natural compounds of anticancer and analgesic properties. Cancer Med. 2016 Oct;5(10):3007-3017. doi: 10.1002/cam4.816. Epub 2016 Sep 30. PMID: 27696789; PMCID: PMC5083753.

⁴Irrera N, D'Ascola A, Pallio G, Bitto A, Mazzon E, Mannino F, Squadrito V, Arcoraci V, Minutoli L, Campo GM, Avenoso A, Bongiorno EB, Vaccaro M, Squadrito F, Altavilla D. beta-caryophyllene Mitigates Collagen Antibody Induced Arthritis (CAIA) in Mice Through a Cross-Talk between CB₂ and PPAR-γ Receptors. Biomolecules. 2019 Jul 31;9(8):326. doi: 10.3390/biom9080326. PMID: 31370242; PMCID: PMC6723248.

⁵Baradaran Rahimi V, Askari VR. A mechanistic review on immunomodulatory effects of selective type two cannabinoid receptor beta-caryophyllene. Biofactors. 2022 Jul;48(4):857-882. doi: 10.1002/biof.1869. Epub 2022 Jun 1. PMID: 35648433.

⁶Bahi A, Al Mansouri S, Al Memari E, Al Ameri M, Nurulain SM, Ojha S. β-Caryophyllene, a CB₂ receptor agonist produces multiple behavioral changes relevant to anxiety and depression in mice. Physiol Behav. 2014 Aug;135:119-24. doi: 10.1016/j.physbeh.2014.06.003.

^AMüller-Vahl K, Grotenhermen F. Medizinisches Cannabis: Die wichtigsten Änderungen. Deutsch Ärztebl. International 2017

^BHorlemann J, Schürmann N. DGS-Praxisleitlinie Cannabis in der Schmerzmedizin. Version: 1.0 für Fachkreise. Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. 2018

Die angegebenen medizinischen Wirkungen beziehen sich auf mögliche Effekte des dominantesten Terpens in der Blüte. Die Angaben sind lediglich ein Anhaltspunkt für die passende Produktauswahl durch das medizinische Fachpersonal und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.